HERNIORRAFIA INGUINAL

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Juan José Gutiérrez Adrián, Beatriz Guil Ortiz

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La hernia inguinal es la protrusión de parte del contenido abdominal a través de un defecto de la pared en la región inguinal, pudiendo incluir epiplón, asas intestinales y, en casos menos frecuentes, la vejiga. Esto ocurre por debilidad del trayecto inguinal (hernia indirecta) o del triángulo de Hesselbach (hernia directa), y puede manifestarse como tumefacción inguinal, dolor o sensación de peso, especialmente con esfuerzos.

El tratamiento quirúrgico busca reducir el saco herniario y reforzar de forma duradera la pared posterior del canal inguinal. En la práctica actual, esto se logra mediante hernioplastia con colocación de malla en el espacio preperitoneal, lo que disminuye la tensión sobre los tejidos y reduce la recidiva.

En cirugía mínimamente invasiva existen dos abordajes endoscópicos principales: el Transabdominal Preperitoneal (TAPP) y el Totalmente Extraperitoneal (TEP). Ambos comparten la filosofía de reparar la hernia desde el espacio preperitoneal con malla, pero difieren en la vía de acceso. El TAPP entra en cavidad peritoneal, abre peritoneo para llegar al plano preperitoneal, coloca la malla y finalmente cierra el peritoneo sobre ella. Esto permite una visión amplia de la anatomía inguinal y la exploración del lado contralateral. El TEP, en cambio, crea el espacio preperitoneal sin acceder a la cavidad abdominal, evitando la agresión intraperitoneal. Suele requerir una disección más exigente y una curva de aprendizaje mayor.

En este capítulo se describe la reparación robótica TAPP, aprovechando la visión tridimensional, la precisión de la disección y la ergonomía de la plataforma robótica para trabajar con seguridad en un espacio anatómico complejo.

Abordajes mínimamente invasivos para hernia inguinal

Objetivo común:
Reparación con malla en el espacio preperitoneal

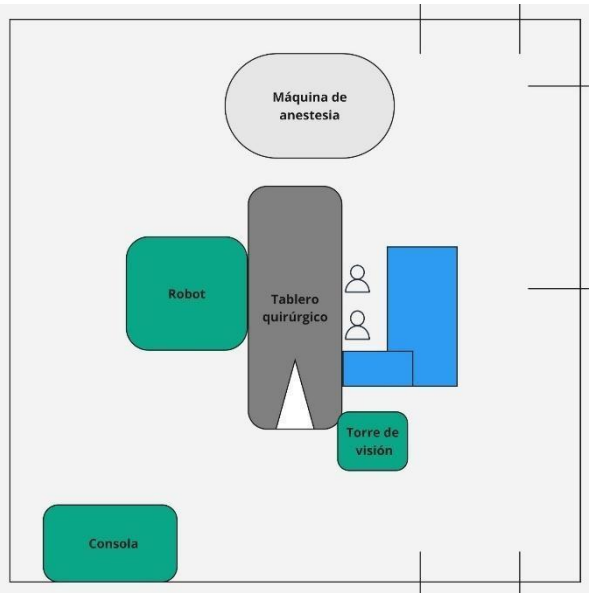
TAPP (Transabdominal preperitoneal)	TEP (Totalmente extraperitoneal)
1. Acceso a cavidad peritoneal	1. Creación del espacio preperitoneal sin entrar en cavidad
2. Incisión del peritoneo → entrada al plano preperitoneal	2. Disección preperitoneal extracavitaria
3. Colocación de la malla + cierre del peritoneo sobre ella	3. Colocación de la malla en el plano preperitoneal

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

- Decúbito supino con brazos alineados con el cuerpo.
- Piernas cerradas.

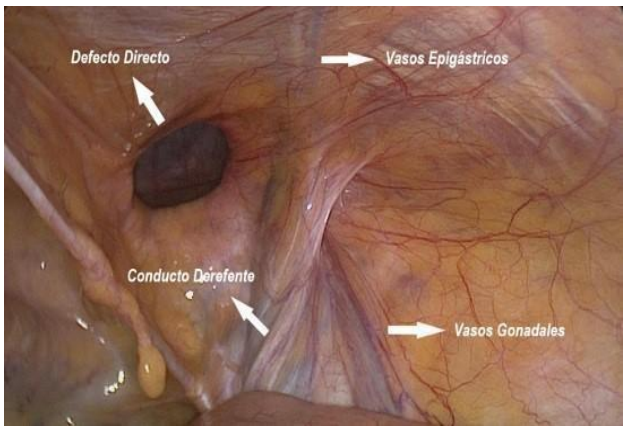
POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

- Anatomía: pélvica
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Bipolar maryland
  - Brazo 2: Endoscopio 30º
  - Brazo 3: Bipolar fenestrada / Tijera

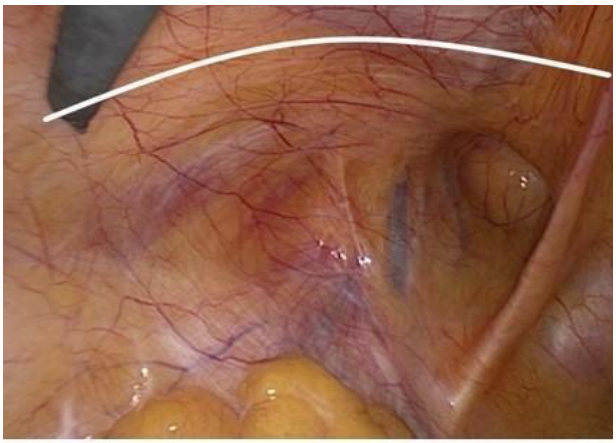


TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Colocación de campo quirúrgico y trócares. En esta cirugía se usan tres trócares robóticos y uno accesorio.
- Visualización del plano quirúrgico y reconocimiento de las estructuras anatómicas de la región inguinal: vasos epigástricos, cordón espermático con sus vasos gonadales y conducto deferente, orificio inguinal y saco herniario con su contenido.



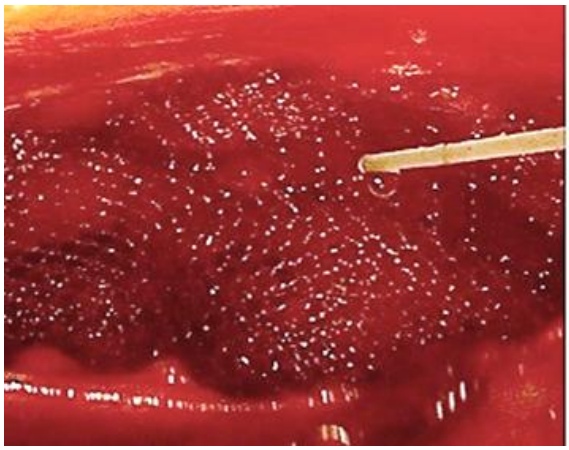
- Apertura del peritoneo parietal por encima del orificio inguinal.
- Por vía preperitoneal se accede al orificio inguinal y se visualiza el cordón. Se diseca el saco herniario, separándolo de los elementos del cordón con especial atención al conducto deferente y sus vasos.

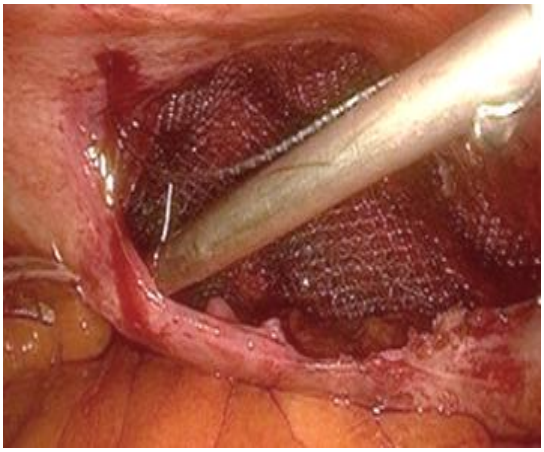


Línea de sección de peritoneo.

Una vez liberado totalmente el saco, se termina de reintroducir en la cavidad peritoneal.

- Se recorta la malla al tamaño necesario y se introduce enrollada por el trocar. Suelen usarse mallas de polipropileno.
- Se adhiere al tejido en un primer momento con el pegamento cianoacrílico específico tipo *Histoacryl*. Importante tener cuidado en su manipulación porque puede quedarse adherido a las paredes de la cánula de aplicación, por lo que se recomienda no purgarlo nunca hasta el momento de usarlo, y tener preparada una jeringa con aire para terminar de empujar el pegamento que pueda haberse quedado en el trayecto.
- Se refuerza la malla con puntos sueltos de prolene 2-0 cortados a 18cm.





- Se vuelve a cerrar el peritoneo abierto al inicio de la cirugía con sutura tipo V-loc de 2-0 o 3-0.
- Si fuese una herniorrafia bilateral, se comenzaría mismo procedimiento en el otro espacio inguinal.



- Revisión de hemostasia y cierre de heridas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Martínez S, Cancino C, Vera A, Palma C, Kerkebe M, San Juan M, Guzmán S. Hernioplastía inguinal asistida por robot: revisión bibliográfica, descripción de la técnica quirúrgica y nuestra experiencia inicial. Revista Chilena de Urología.2016;81(3):23-26
2. Iossa A, Traumueller Tamagnini G, De Angelis F, Micalizzi A, Lelli G, Cavallaro G. TEP or TAPP: who, when, and how? Front Surg. 2024;11:1352196. doi:10.3389/fsurg.2024.1352196.
3. Ferzli G, Iskandar M. Laparoscopic totally extra-peritoneal (TEP) inguinal hernia repair. Ann Laparosc Endosc Surg. 2019;4:??. doi:10.21037/ales.2019.03.03.
4. Jung S, Lee HS. A Practical Guide to Robotic Transabdominal Preperitoneal Repair for Inguinal Hernia. J Surg Innov Educ. 2025;2(1):1-4. doi:10.69474/jsie.2025.00052.
5. Rivero-Moreno Y, Goyal A, Redden-Chirinos S, Bulut H, Dominguez-Profeta R, Munnangi P, et al. Clinical outcomes from robotic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair in patients under and over 70 years old: a single institution retrospective cohort study with a comprehensive systematic review. Aging Clin Exp Res. 2025;37:3. doi:10.1007/s40520-024-02890-9.